在宅看取り場所一致率 ―― 全スタッフ向けスライド（20分）

参考文献

2026-03-30 ・ AI（Claude）作成・主な出典は原典で確認

最期の場所が「希望通り」であること
― 患者さんとご家族にとっての意味

- 「自分で選んだ場所で最期を迎えられた」という安心感
- ご家族にとっては「約束を守れた」という心の支え
- 反対に、希望と違う場所での看取りは、遺族の後悔につながることがある

問いかけ:「あなたが関わった患者さん・利用者さんは、希望通りの場所で最期を迎えられましたか？」

今日の学習目標

1. トランジション（場の移行）における自分の職種の役割を説明できる
2. 家族支援の具体的アプローチを3つ挙げられる
3. 急変時の連携フローを知り、自分がとるべき行動を理解する

すべての職種に関係するテーマです。「私には関係ない」ではなく、「私にもできることがある」を見つけましょう

ACP(アドバンス・ケア・プランニング)とは？

- **一言でいうと**:「これからのことを、本人・ご家族・私たちで一緒に話し合い続けること」
- 一度決めたら終わりではなく、状況が変わるたびに何度でも話し合う
- 「人生会議」という愛称でも知られている
- 紙に書くことより、**対話のプロセスそのもの**が大切

  大切なポイント: 患者さんの気持ちは変わることがある。だからこそ「繰り返し」が重要

研究が教えてくれたこと(数字を身近に)

緩和ケア病棟から自宅に退院した患者さん359人の遺族調査(2018年)

- **自宅で亡くなった方:** 100人いたら**80人**は、事前の方針通りの場所で最期を迎えられた
- **緩和ケア病棟で亡くなった方:** 100人いたら**82人**は、方針通り

でも裏を返すと...

- **100人のうち約20人**は、方針と違う場所で亡くなっている
- しかもこれは、緩和ケア病棟を経験した、**専門的な支援を受けた方たち**の数字

海外の研究では、一致率は21%~100%と研究ごとに大きく違います(定義や対象が異なるため、単純な比較はできません)。この数字が示すように、改善の余地はまだあります

100人いたら80人、82人



約5人に1人（100人のうち約20人）は、事前の方針と違う場所で亡くなっている

緩和ケア病棟を経験した患者の遺族での数値

佐藤桃香ほか, Palliat Care Res 2026;21(1):31-39

不一致が起きる理由

自宅での看取りが叶わなかった主な理由

- **痛みの管理が難しかった** ― 在宅では24時間の対応が難しい場面がある
- **在宅で対応できる医師がいなかった** ― 地域によって医師の数に大きな差がある
- **ご家族の介護負担が限界を超えた** ―「見ていられない」という心理的つらさも

逆に「病棟の予定だったけど自宅で看取れた」ケースも

- 在宅医療に対応してくれる医師・看護師が見つかった（ポジティブな変化）

あなたの職種でできること(1)

看護師

- 退院前カンファレンスでの情報引き継ぎ
- 症状変化の早期発見と医師への報告
- ご家族への症状管理の教育(レスキュー薬の使い方など)

ソーシャルワーカー(SW)/ 医療相談員

- 在宅サービスの調整(訪問診療、訪問看護、介護保険)
- ご家族の経済的・社会的不安への対応
- バックアップベッド(急変時の再入院先)の事前確保

ケアマネジャー

- 介護サービスの迅速な調整
- ご家族のレスパイト(休息)支援の計画
- 在宅チーム全体の連携の要

あなたの職種でできること(2)

薬剤師

- レスキュー薬(痛み止め)の事前配置と使い方の説明
- 服薬管理のサポート
- 医師との薬剤調整の橋渡し

介護職

- 日々のケアの中での「いつもと違う」の気づき
- 学会員への調査では、介護従事者向けの地域教育活動を行っているという回答は約1割にとどまった
- **あなたの「気づき」が、医療チームへの大切な情報になる**

  現実の課題: 介護職向けの緩和ケアの教育活動は、まだ十分に広がっていない

まとめ

ご家族への声かけ — 明日から使える3つのアプローチ

1. 不安を受け止める声かけ

- 「夜、ひとりで見ているのは不安ですよね。何かあったらいつでも連絡してください」
- 「がんばりすぎていませんか？あなたの体も大切です」

2. 急変時に備える声かけ

- 「もし急に痛みが強くなったら、まずこのお薬を使ってください。そのあと〇〇に電話してください」
- 「夜間の連絡先はここに貼っておきますね」

3. 看取りに向けた心の準備の声かけ

- 「ご本人の希望を、改めて確認しておきましょうか」
- 「今のお気持ちを聞かせていただけますか？何でも大丈夫ですよ」

グループワーク（5分）「自分の職種でできること」

お題

隣の人と話し合ってください:

> *「緩和ケア病棟から自宅に戻った患者さんが、希望通りの場所で最期を迎えるために、**あなたの職種**でできることは何ですか？」*

考えるヒント

- 退院前にできること
- 退院直後にできること
- 在宅療養中にできること
- 急変時にできること

正解はありません。「自分ならこうする」を考えてみてください

今日から始める、あなたのアクション

職種別の「まず1つ」

職種	明日からの1アクション
看護師	退院前カンファレンスで「急変時の連絡先」を必ず確認する
介護職	「いつもと違う」を感じたら、その日のうちに看護師に伝える
SW/相談員	バックアップベッドの確保状況を退院前にチェックする
ケアマネ	家族のレスパイトニーズを月1回は確認する
薬剤師	レスキュー薬の配置と使い方を家族に説明する

今日から始める、あなたのアクション（続き）

参考資料

- 佐藤桃香ほか. Palliative Care Research 2026;21(1):31-39
- 川島有沙ほか. Palliative Care Research 2026;21(1):69-73
- 日本版ACP定義: acp-japan.org

「自分には関係ない」→「自分にもできることがある」